

Dizanteri (Kanlı-Mukuslu İshal)

İnvaziv kolitin ayırıcı tanısını, dışkı tetkik algoritmasını, ampirik antibiyotik endikasyonunu ve STEC/HÜS güvenlik durdurmasını yapılandıran karar aracı; enfeksiyöz dizanteriyi alerjik proktokolit ve İBH'den ayırmaya odaklanır. Hedef kitle: çocuk gastroenteroloji uzmanı.

İnvaziv kolit

Dışkı tetkik

STEC / HÜS

İBH-alerjik kolit ayrımı

01 Tanım ve ilk değerlendirme

Dizanteri; kolonik mukozanın invaziv-inflamatuvar hasarına bağlı, dışkıda gözle görülür kan ve mukus ile seyreden, sık ve az miktartlı defekasyon, tenesmus ve karın krampı ile karakterli klinik tablodur. İlk görev üç ayrımı yapmaktır: (1) gerçek kanlı-mukuslu invaziv ishal mi, yoksa üst GİS kanamasının, yutulmuş kanın (anne memesi çatlağı, epistaksis), anal fissürün ya da gıda/ilaç kaynaklı yalancı kırmızılığın (pancar, jelatin, rifampin, sefdinir) taklidi mi; (2) akut (<2 hafta) enfeksiyöz kolit mi, yoksa kronik/tekrarlayan zeminde İBH mi; (3) süt çocuğunda iyi görünümlü, izole kanlı-mukuslu gaita — inek sütü proteinine bağlı alerjik proktokolit mi. Kritik ilk kararlar hidrasyon durumunun derecelendirilmesi ve STEC (Shiga toksin üreten E. coli) olasılığının erkenden tanınmasıdır; çünkü STEC şüphesi antibiyotik ve antimotilite ilaçlarını kontrendike kılar (HÜS tetikleme riski).

Önce yalancı kanamayı dışla

Akut enfeksiyöz vs kronik İBH

Süt çocuğunda alerjik proktokolit

STEC → antibiyotik/antimotilite YOK

Öyküde sorgula

- Dışkı: kanın niteliği (dışkıya karışık mı, üzerinde çizgi mi), mukus, hacim, sıklık, tenesmus; başlangıç ve süre (akut <2 hafta vs. kronik/tekrarlayan)
- Eşlik eden: ateş yüksekliği ve paterni, karın ağrısı-kramp, kusma (safralı mı), kilo kaybı, gece semptomları, büyüme duraklaması (İBH lehine)
- Maruziyet: kreş, salgın teması, iyi pişmemiş kıyma/hamburger, çiğ süt, kümes-sürünge teması (Salmonella), kontamine su, endemik bölge seyahati, yakın zamanda antibiyotik (C. difficile)
- Yaş bağlamı: süt çocuğunda beslenme (inek sütü/formül, anne diyeti), iyi görünüm; süt çocuğunda paroksizmal ağrı + "çilek jölesi" gaita (invajinasyon)
- Konak: yaş <3 ay, immünsüpresyon, orak hücre, hemolitik anemi, İBH öyküsü, aile öyküsü (İBH, çölyak)
- Kırmızı bayrak taraması: idrar azalması, solukluk, peteşi-purpura, letarji (HÜS); artralji-purpurik döküntü (IgA vaskülit)

Muayenede değerlendir

- Hidrasyon/hemodinami: taşikardi, kapiller dolum, göz-fontanel çöküklüğü, turgor, mukoza, idrar çıkışı; toksik görünüm ve şok bulguları
- Ateş ve genel durum: yüksek ateş + tenesmus + toksisite (basilli dizanteri/şigelloz); afebril-subfebril belirgin kanlı ishal (STEC'i düşündürür)

- Batın: yaygın hassasiyet-distansiyon, peritoneal irritasyon (toksik megakolon/perforasyon), sağ üst kadranda sosis kitle (invajinasyon)
- Perianal: fissür, fistül-şekil bozukluğu, deri lezyonu (Crohn lezinye); anal ragad (yalancı kanama kaynağı)
- Ekstraintestinal: solukluk-peteşi-ödem (HÜS), palpabl purpura-artrit (IgA vaskülit/HSP), aftöz stomatit-eritema nodozum-clubbing (İBH)
- Büyüme: persantil kaybı, boy-kilo duraklaması (kronik/İBH)

Kırmızı çizgi: Toksik görünüm, şok, peritonit, <3 ay süt çocuğunda kanlı ishal veya HÜS bulgusu (oligüri, solukluk, peteşi) varsa değerlendirme resüsitasyonla eşzamanlı yürütölür. Kanlı ishalleri her çocukta **STEC olasılığı dışlanana dek ampirik antibiyotik ve antimotilite ajanlarından kaçınılır.**

Kanlı-mukuslu ishal esas olarak invaziv/inflamatuvar bir kolit tablosudur; etkenler mukozayı invaze eder veya sitotoksinle hasarlar, bu da kan, mukus ve dışkı lökositine yol açar. Kategori ayrımı hem tetkik seçimini hem de en kritik noktayı — antibiyotik verilip verilmeyeceğini — belirler.

Shigella (basilli dizanteri)

- Klasik dizanteri etkeni; yüksek ateş, tenesmus, sık az hacimli kanlı-mukuslu gaita, toksisite; nöbet-ensefalopati yapabilir
- Az inokulumla bulaşır (fokal-oral, kreş salgını); Shiga toksin üreten *S. dysenteriae* tip 1 HÜS yapabilir
- Antibiyotik süreyi ve bulaşı azaltır — ampirik tedaviden en çok yarar gören etken

STEC / EHEC (O157:H7 ve diğerleri)

- Çoğu afebril-subfebril, belirgin kanlı ishal + şiddetli karın ağrısı; iyi pişmemiş kıyma, çiğ süt, temas
- Shiga toksin (stx1/stx2) → tipik HÜS'ün başlıca nedeni (özellikle <5 yaş)
- **Antibiyotik ve antimotilite HÜS riskini artırır — verilmez;** yönetim yalnızca destektir

Campylobacter · Salmonella · Yersinia

- Campylobacter: kanlı ishal + karın ağrısı; erken azitromisin süreyi kısaltır (Guillain-Barré ilişkisi)
- Non-tifoidal Salmonella: genelde kendini sınırlar — rutin antibiyotik YOK; yalnız <3 ay, immünsüpresyon, bakteriyemi riskinde tedavi
- Yersinia: terminal ileit/psödoapandisit, mezenterik lenfadenit; apandisit taklit eder

Parazitik ve C. difficile

- Entamoeba histolytica: subakut kanlı-mukuslu ishal, endemik bölge/seyahat; amip antijeni/PCR E. dispar'dan ayırır
- C. difficile: yakın antibiyotik kullanımı; <1 yaşta asemptomatik taşıyıcılık sık — pozitif test dikkatle yorumlanır
- Toksik megakolon riski; ağır olguda vankomisin

Alerjik (inek sütü) proktokolit

- Tipik süt çocuğu: iyi görünümlü, büyümesi normal, izole kan-mukus çizgili gaita; anne sütü veya formül alan bebek
- İnek sütü proteini ($\pm$ soya) tetikler; ateş-toksisite YOK, dehidratasyon beklenmez
- Tanı diyet eliminasyonuna yanıtla konur; endoskopi genelde gerekmez

İBH ve cerrahi/vasküler nedenler

- İBH (ülseratif kolit/Crohn): kronik/tekrarlayan kanlı-mukuslu ishal, gece semptomu, kilo kaybı, büyüme duraklaması, ekstraintestinal bulgu
- İnvaginasyon (3 ay-3 yaş, paroksizmal ağrı + "çilek jölesi"), Meckel divertikülü (ağrısız masif kanama)
- IgA vaskülit (HSP): palpabl purpura + artrit + karın ağrısı + kanlı gaita

Yaş kuralı: Süt çocuğunda iyi görünümlü izole kanlı-mukuslu gaita → önce alerjik proktokolit; 3 ay-3 yaşta paroksizmal ağrı + çilek jölesi gaita → invaginasyon; okul çağı-adölesanda kronik/tekrarlayan kanlı

ishal + kilo kaybı → İBH; akut yüksek ateş + tenesmus + toksisite → şigelloz; afebril belirgin kanlı ishal + çiğ et teması → STEC (HÜS izle).

03 Karar akışı

İlk çatal toksik/dehidrate-şok tablosudur; ikinci ve en kritik çatal STEC olasılığıdır (antibiyotik durdurma noktası); üçüncü çatal, enfeksiyöz zemin dışlandığında alerjik proktokolit / İBH ayrımıdır.

BAŞLANGIÇ

Kanlı-mukuslu ishal (dizanteri)

Gerçek invaziv kolit mi doğrula — üst GİS kanaması, yutulmuş kan, anal fissür ve gıda/ilaç kaynaklı yalancı kırmızılığı dışla.

ADIM 1

Hidrasyonu derecele + ORS ile stabilize et

Dehidratasyon derecesi ve vital; düşük ozmolariteli ORS başla, çinko ekle, beslenmeyi sürdür; öyküde ateş paterni, maruziyet (çiğ et, seyahat, antibiyotik), yaş ve konak riskini topla.

KARAR 1

Toksik görünüm / şok / <3 ay / immünsüpresyon var mı?

Septik-toksik tablo, ağır dehidratasyon-şok, süt çocuğu <3 ay, immün yetmezlik veya ağır sistemik hastalık.

EVET → Yatış + ampirik tedavi

HAYIR → Ayaktan yönetim

ACİL

Hastaneye yatır, IV resüsitasyon + kan+dışkı kültürü, ampirik parenteral seftriakson

İzotonik bolus, kültür sonrası ampirik seftriakson 50 mg/kg/gün (maks 2 g); STEC testini gönder ve HÜS için hemogram-şistosit-kreatinin izle.

KATMANLA

Dışkı panelini gönder, oral hidrasyonla izle

Dışkı kültürü + STEC (Shiga toksin/stx PCR) + inflamasyon belirteci; ampirik antibiyotiği STEC dışlanana ve endikasyon netleşene dek beklet.

KARAR 2

STEC/EHEC olasılığı yüksek mi?

Afebril-subfebril belirgin kanlı ishal + şiddetli karın ağrısı, çiğ kıyma/çiğ süt teması veya salgın; <5 yaş.

EVET → Güvenlik durdurması

DUR

Yalnızca destek — ANTİBİYOTİK ve ANTİMOTİLİTE VERME

Antibiyotik ve loperamid HÜS riskini artırır; IV izotonik sıvı ile böbreği koru, seri tam kan-periferik yayma-üre/kreatinin ile HÜS izle.

HAYIR → Şigelloz olası

TEDAVİ ET

Ampirik azitromisin + kültür

Yüksek ateş + tenesmus + toksisite basilli dizanteriyi (Shigella/Campylobacter) düşündürür; ampirik azitromisin başla, kültüre göre daralt.

KARAR 3

Enfeksiyöz zemin dışlandı / süt çocuğu iyi görünümlü / kronik-tekrarlayan mı?

Kültür-panel negatif ve semptom süregen; ya da süt çocuğunda iyi görünümlü izole kanlı gaita; ya da >2-4 hafta kronik/tekrarlayan tablo, kilo kaybı, büyüme duraklaması.

EVET → Non-enfeksiyöz araştır

AYIR

**Süt çocuğu → alerjik proktokolit;
büyük çocuk → İBH işlemi**

Süt çocuğunda inek sütü proteini eliminasyonu (yanıt tanısaldır); kronik/atipik olguda fekal kalprotektin, inflamasyon-anemi paneli ve ileokolonoskopi + biyopsi ile İBH değerlendir.

HAYIR → Kendini sınırlayan kolit

İZLE

Destekleyici bakım + güvenlik ağı

Çoğu enfeksiyöz dizanteri kendini sınırlar; hidrasyon-çinko-beslenme sürdür, kötüleşme/HÜS bulgusu için net dönüş talimatı ver.

Tetkik dışkı mikrobiyolojisi ve inflamasyon belirteçleri üzerine kuruludur; kanlı ishalde STEC testi rutin olarak ilk basamak dışkı panelinin parçası olmalıdır (HÜS öngörüsü ve antibiyotik kararı için). Kronik/atipik olguda endoskopi İBH tanısını netleştirir; toksik/HÜS şüphesinde kan tetkiki paralel yürütülür.

Kanlı-mukuslu ishalde kademeli tetkik		
BASAMAK	TEST	AMAÇ / NOT
Basamak 1 · Yatak başı	Kanın makroskopik doğrulanması + gizli kan, hidrasyon-vital, kapiller glukoz, kilo/persantil	Yalancı kanamayı (gıda/ilaç, yutulmuş kan, fissür) dışla; dehidratasyon derecesi tedaviyi yönlendirir
Basamak 2 · Dışkı mikrobiyolojisi	Dışkı kültürü (Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinia) + STEC testi: Shiga toksin EIA ve stx1/stx2 PCR, sorbitol-MacConkey (O157); ± multipleks GİS PCR paneli	Kanlı ishalde STEC testi zorunludur; kültür negatifse bile toksin/PCR ile STEC aranır. Panel pozitifliğini klinikle yorumla
Basamak 3 · Dışkı inflamasyonu	Fekal lökosit/laktoferrin; fekal kalprotektin; risk varsa dışkı C. difficile toksin/GDH (± PCR)	İnvazivliği destekler; yüksek kalprotektin İBH'yi düşündürür (özgül değil). <1 yaşta C. difficile taşıyıcılığı sıktır — pozitifliği dikkatle yorumla
Basamak 4 · Parazit	Dışkıda E. histolytica antijeni/PCR; yumurta-parazit (3 örnek)	Endemik bölge/seyahat, subakut seyir; mikroskopi E. histolytica'yı apatojen E. dispar'dan ayıramaz — antijen/PCR gerekir

BASAMAK	TEST	AMAÇ / NOT
Basamak 5 · Kan / HÜS izlemi	Tam kan + periferik yayma (şistosit), üre-kreatinin, LDH, haptoglobin, elektrolit, CRP; ağır olguda kan kültürü	Anemi + trombositopeni + akut böbrek hasarı = HÜS; STEC pozitif/riskli olguda seri izle. CRP/anemi/trombositoz İBH aktivitesini destekler
Basamak 6 · Endoskopi / görüntüleme	Kronik/İBH şüphesinde ileokolonoskopi + üst endoskopi ve biyopsi; invajinasyonda USG; Meckel için Tc-99m perteknetat sintigrafisi	Porto kriterlerine göre İBH tanısı için segmental biyopsi zorunlu; süt çocuğu alerjik proktokolitte endoskopi genelde gereksiz
Seçili · İBH paneli	Tam kan, ESR/CRP, albümin, ferritin, çölyak serolojisi; gaita kalprotektin izlemi	Kronik kanlı ishalde beslenme-inflamasyon durumu; enfeksiyöz nedenler İBH tanısı öncesi dışlanır

Not: Ampirik antibiyotik kararı verilmeden önce dışkı kültürü ve STEC testi **alınmış olmalıdır**; antibiyotik STEC dışlanmadan başlanırsa hem kültür verimini düşürür hem de STEC olgusunda HÜS riskini artırır. Kültür negatif ama klinik süregen/atipikse tetkik İBH ve parazit yönünde derinleştirilir.

Aşağıdakilerden herhangi biri hastaneye yatış, ivedi tetkik ve — HÜS/STEC dışında — hedefli tedavi gerektirir; STEC bulguları ise antibiyotik ve antimotiliteyi durdurur.

- HÜS üçlüsü: solukluk-anemi + peteşi/trombositopeni + oligüri/böbrek hasarı

- Afebril belirgin kanlı ishal + çiğ et/çiğ süt teması (STEC — antibiyotik/antimotilite VERME)

- Toksik görünüm, yüksek ateş, letarji, nöbet-ensefalopati (ağır şigelloz)

- Ağır dehidratasyon / hipovolemik şok / idrar çıkışında azalma

- <3 ay süt çocuğunda kanlı ishal (invaziv bakteriyel enfeksiyon-bakteriyemi riski)

- İmmünsüpresyon, orak hücre veya bilinen İBH zemininde kanlı ishal

- Batın distansiyonu + peritonit bulgusu (toksik megakolon / perforasyon)

- Paroksizmal ağrı + "çilek jölesi" gaita + sosis kitle + letarji (invajinasyon)

- Masif ağrısız rektal kanama (Meckel divertikülü)

- Palpabl purpura + artrit + karın ağrısı (IgA vaskülit / HSP)

- Kronik/tekrarlayan kanlı ishal + kilo kaybı + gece semptomu + büyüme duraklaması (İBH)

- Süt çocuğunda kötü görünüm, kilo kaybı, kanlı ishal (basit alerjik proktokolitle uyumsuz)

Tüm dizanteride temel yönetim hidrasyon (oral rehidratasyon), çinko takviyesi ve erken beslenmedir; antimotilite ajanları (loperamid) invaziv kolitte ve özellikle STEC'te kontrendikedir. Antibiyotik seçici bir kararla verilir: en çok yarar sağlanan şigellozda, ağır/sistemik olguda ve tanımlı etkende; STEC'te ise verilmez. Etkene özgü tedavi kültür/toksin sonucuna göre daraltılır.

Temel ve destekleyici tedavi	
BASAMAK / İLAÇ	DOZ
Oral rehidrasyon sıvısı (düşük ozmolariteli ORS)	Hafif-orta dehidratasyonda 50-100 mL/kg 4 saatt
Çinko takviyesi	<6 ay 10 mg/gün; ≥6 ay 20 mg/gün, 10-14 gün
Beslenmenin sürdürülmesi	—
Ondansetron (eşlik eden kusmada)	0,15 mg/kg/doz PO/IV (maks 8 mg/doz)
Antimotilite (loperamid)	Verilmez (KONTRENDİKE)

BASAMAK / İLAÇ	DOZ
Etkene özgü antimikrobiyal tedavi	
ETKEN	TEDAVİ / DOZ
Shigella (şigelloz)	Azitromisin 12 mg/kg gün 1 (maks 500 mg), ardından 6 mg/kg/gün (m
Campylobacter	Azitromisin 10 mg/kg/gün (maks 500 mg) 3 gün
Non-tifoidal Salmonella	Rutin antibiyotik YOK; endikasyonda seftriakson 50-75 mg/kg/gün (m
STEC / EHEC (O157:H7 vb.)	Antibiyotik ve antimotilite VERİLMEZ; yalnız destek + IV izotonik hidr
Entamoeba histolytica	Metronidazol 35-50 mg/kg/gün 3 doz (maks 750 mg/doz) 7-10 gün, ard

ETKEN	TEDAVİ / DOZ
Clostridioides difficile	Non-ağır: metronidazol PO 30 mg/kg/gün 3-4 doz (maks 500 mg/doz)

Alerjik proktokolit: İyi görünümlü süt çocuğunda inek sütü proteini eliminasyonu tedavidir — anne sütü alan bebekte anneden inek sütü ($\pm$ soya) çıkarılır; formül alanda aşırı hidrolize (gerekirse aminoasit bazlı) formüle geçilir. Yanıt genelde 2-4 haftada; kanama düzelir. Antibiyotik gereksizdir.

İBH: Kronik/tekrarlayan kanlı-mukuslu ishalde enfeksiyöz nedenler dışlanıp Porto kriterleriyle tanı doğrulandıktan sonra hastalık yaygınlığı ve şiddetine göre indüksiyon (ör. ülseratif kolitte 5-ASA $\pm$ steroid, uygun olguda eksklüzif enteral beslenme veya biyolojik) planlanır; ateş/kanlı ishalde önce süperenfeksiyon (C. difficile, CMV) ekarte edilir.

Enfeksiyöz dizanterinin çoğu kendini sınırlar; yönetim hidrasyonu korumak, STEC olgusunda HÜS'ü erken yakalamak ve enfeksiyöz olmayan (alerjik proktokolit, İBH) tabloları zamanında tanımak üzerine kuruludur. Hedef: gereksiz antibiyotikten kaçınırken tedavi gereken etkeni tedavi etmek ve güvenli takip sağlamak.

İzlem ve HÜS gözetimi

- STEC pozitif/şüpheli olguda ilk 7-10 gün HÜS açısından seri tam kan (trombosit), periferik yayma (şistosit), üre-kreatinin ve idrar çıkışı izle
- Hidrasyonu koru; STEC'te erken IV izotonik sıvı böbreği korur (dehidrasyondan kaçın), antibiyotik-antimotilite verme
- Kültüre göre ampirik tedaviyi daralt/durdur; Salmonella'da taşıyıcılığı uzatmamak için gereksiz antibiyotiği kes
- Kültür-panel negatif ama semptom süregen/atipikse parazit ve İBH yönünde ilerle; alerjik proktokolitte eliminasyon yanıtını (2-4 hafta) değerlendir
- Bulaş kontrolü: el hijyeni, kreş/okula dönüş kriterleri, gıda güvenliği eğitimi; bildirim zorunlu etkenlerde ihbar

Taburculuk ve güvenlik ağı

- Taburculuk: oral tolerans, yeterli idrar çıkışı, kontrol altında hidrasyon ve güvenilir bakım verici
- Aileye yazılı uyarı: idrar azalması, solukluk, peteşi-morarma, ödem, letarji (HÜS); inatçı kanama, yüksek ateş, karın şişmesi-şiddetli ağrıda acil dönüş
- Süt çocuğu alerjik proktokolitte planlı yeniden yükleme (rechallenge) ile tanıyı doğrula ve tolerans gelişimini izle
- İBH tanısı alan çocukta remisyon-idame, büyüme-beslenme ve kalprotektin ile aktivite takibi
- Belirlenmiş erken tekrar değerlendirme planla; "kültür negatif" tanıyı sonlandırmaz — klinik seyir yönlendirir

En güvenli sonuç; yalancı kanamayı dışlayan, dışkı panelini (STEC dahil) baştan gönderen, ampirik antibiyotiği yalnız endikasyonda ve STEC dışlandıktan sonra kullanan, HÜS'ü seri izlemle yakalayan ve enfeksiyöz olmayan nedenleri (alerjik proktokolit, İBH) zamanında ayıran yapılandırılmış bir planla elde edilir.

Kaynaklar

1. Shane AL, Mody RK, Crump JA, et al. 2017 IDSA Clinical Practice Guidelines for the Diagnosis and Management of Infectious Diarrhea. Clin Infect Dis. 2017;65(12):e45-e80.
2. Guarino A, Ashkenazi S, Gendrel D, et al. ESPGHAN/ESPID Evidence-Based Guidelines for the Management of Acute Gastroenteritis in Children in Europe: Update 2014. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2014;59(1):132-152.
3. Levine A, Koletzko S, Turner D, et al. ESPGHAN Revised Porto Criteria for the Diagnosis of Inflammatory Bowel Disease in Children and Adolescents. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2014;58(6):795-806.
4. Meyer R, Chebar Lozinsky A, Fleischer DM, et al. Diagnosis and management of Non-IgE gastrointestinal allergies in breastfed infants — an EAACI Position Paper. Allergy. 2020;75(1):14-32.

Uyarı: Bu belge uzman kullanıcıya yönelik bir klinik karar destek aracıdır; hastanın bireysel değerlendirmesi, güncel kılavuzlar ve yerel direnç/uygulama verilerinin yerine geçmez. Dozlar hastaya, ağırlığa, komorbiditeye, bölgesel duyarlılığa ve ilaç etkileşimlerine göre teyit edilmelidir.